

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 14:43:51

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Miguel Angel Padilla Padilla
Edad : 54a 4m 8d
Dirección : Altamira 2736 V Don Ramon

Rut : 12.057.715-8
Fecha Nacto: 18/12/1967
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0130877
Sexo : Masculino
Teléfono : 933078268

N° Epicrisis
303092

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utac/ Utinx

Fecha Ingreso : 24/03/2022 22:19

Días Estadía: 33

Unidad de Egreso : Neurología / Neurocirugía

Fecha Egreso : 26/04/2022 14:04

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hemiparesia FBC izquierda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Fecha ingreso a CASR: 24/03/2022
Fecha ingreso a UTAC: 25/03/2022
Fecha ingreso a UPC: 03/04/2022
Fecha reingreso a UTAC: 13/04/2022
Fecha ingreso a sala neurología: 21/04/2022

Paciente de 54 años, diestro, mRs2 (por incontinencia urinaria)

Antecedentes Personales:

Antecedentes médicos: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 no insulino dependiente

Quirúrgicos: fractura pierna derecha, fractura de pelvis hace 1 año.

Medicamentos: losartán 50 mg/día

Alergias: no refiere

Hábitos: drogas (-); OH ocasional (menos de 1 vez por semana); tabaquismo: suspendido en 2020 (IPA 15 paq-año)

Social: trabaja como mecánico de motores eléctricos en construcción. Egresado de colegio industrial. Vive con su madre.

Inmunizaciones: 3 dosis de COVID

Anamnesis:

El 24/03 a las 18:30 hrs presentó súbitamente paresia braquial izquierda. Por este motivo fue traído por sus familiares a CASR ingresando a las 20:47 hrs (con 1 hr y 17 minutos de evolución). Ingresó en regulares condiciones generales, GCS 15, hipertenso severo (212/118 mmHg), afebril, normocárdico y sin requerimientos de oxígeno suplementario. Se constató hemiparesia izquierda y se activó código stroke. Fue evaluado inmediatamente por neurólogo de turno destacando paciente: vigil, atento, orientado en tiempo y espacio, lenguaje conservado, disartria leve, campo visual normal, oculomotilidad normal, sin asimetría facial, sensibilidad facial normal, pares bulbares normales, paresia M4 (-) braquial izquierda, fluctuante, dudosa paresia crural izquierda, clonus bilateral, plantares extensores bilaterales, sensitivo normal, cerebeloso normal. Se calculó NIHSS de 3 (0-0-0-0-0-0-1-0-1-0-0-0-0-1-0). Dentro del estudio en unidad de urgencia destacó: ECG en ritmo sinusal, sin signos de isquemia; Hcto 41%; Hb 14; leucocitos 13.650; RAN 12100; RAL 1,0; PLQ 252.000, ELP 140/3,5/107, GSV: pH 7,35; pCO2 45,8; pO2 42,4; BE -0,5; Alb 4,6; Ca2+ 9; creatinina 1,01, BUN 20,5; glucosa 128, PCR 0,4; INR 1,1; TTPA 25,5. Se rescató, además, historia consistente en incontinencia urinaria de "meses" de evolución y ataxia de 2 semanas de evolución.

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 14:43

Página 1 de 5

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 14:43:51

Página 2 de 5

Se estudió con tomografía computada (TC) de encéfalo y angioTC de cerebro y cuello donde destacó un hematoma talámico derecho de aproximadamente 6 cc con vaciamiento ventricular (ICH 1). En estudio de vasos destacó dolicoectasia de los vasos intracraneanos, ausencia de comunicante posterior derecha, arteria cerebral derecha hipoplásica.

Evolución en urgencias/UTAC:

Se indicó monitorización invasiva de la presión arterial y se inició BIC de labetalol, logrando PAS cercanas a 160 mmHg. El 25/03 durante la mañana presentó compromiso cualicuantitativo de conciencia, quedando en sopor profundo, por lo que se realizó nuevo TC de encéfalo donde se observó estabilidad del hematoma y sin mayor extensión ventricular.

Se complementó estudio con nuevos exámenes de laboratorio de lo cual destacó: Hcto. 38.5; Hb. 12,9; leucocitos 8.710; plaquetas 242.000; ELP 139/3,41/109; pH 7,46; pCO₂ 33,4; HCO₃ 23,3; BE -0.5; INR 1,19; TTPK 29,8; creatinina 0,77; BUN 14,8. Se solicitó radiografía de tórax que impresionó sin alteraciones.

En el servicio de urgencia se instaló sonda Foley.

Evolucionó en buenas condiciones generales con recuperación de conciencia, manteniendo episodios de agitación esporádicos. El 28/03 presentó alza térmica de probable foco respiratorio por lo que se inició Ampicilina/sulbactam posterior a toma de cultivos. Ante persistencia de sintomatología febril y deterioro de nivel de conciencia se decidió escalar a Tazonam de forma empírica el 02/04.

Durante la noche del 31/03 y el día 01/04 presentó cuadro de agitación por lo que habría recibido diazepam y haldol. Evolucionó con disminución de nivel de conciencia hasta sopor por lo que se controló con TC de encéfalo que no mostró cambios con respecto a estudios previos. Frente a persistencia de compromiso de conciencia y mala protección de vía aérea, se realizó intubación orotraqueal a I segundo intento por anestesista de turno, fijando TOT 8.0 a 24 cm.

En este contexto, se solicitó ingreso a la UCI para completar estudio y manejo.

Evolución en UPC:

Hemodinámico: por hipertensión severa persistente, se inició urapidilo por 4 días, asociado a tratamiento antihipertensivo enteral, con buena respuesta, logrando suspensión de infusión de urapidilo tras instalación de terapia antihipertensiva enteral (isosorbida, hidralazina, losartán y amlodipino) con meta de PAS menor a 160 mmHg.

Respiratorio: a su ingreso estuvo inicialmente conectado a ventilación mecánica invasiva por compromiso de conciencia de causa no precisada. Evolucionó con mejora progresiva de conciencia hasta vigilia, lográndose weaning el día 10/04/22. Al momento del traslado, sin requerimiento de oxigenoterapia.

Infeccioso: el 02/04 el cultivo de secreción traqueal salió positivo para *Serratia marcescens*, por lo que se mantuvo Tazonam. El 10/04 presentó nuevo peak febril, por lo cual se tomaron nuevos hemocultivos, saliendo éstos positivos a las 9 y 11 hrs para bacterias Gram negativos, con FilmArray que confirmó presencia de *Enterobacter* y *Serratia marcescens*, por lo que se cambió tratamiento antibiótico a meropenem el día 11/04. Se mantuvo con leucocitos estacionarios. Sin criterios de cuadro séptico, sin requerimiento de drogas vasoactivas, se manejó peak febriles aislados dentro de medidas de neuroprotección.

Neurológico: el día del ingreso a UPC se inició fenitoína por sospecha de crisis comiciales con compromiso de conciencia. Se realizó TC cerebro de control, sin cambios del hematoma, con aumento de edema perilesional. Al examen neurológico tras extubación destacó con hemiparesia hemicuerpo izquierdo M2 con disartria moderada a severa. Evolucionó con fluctuaciones marcadas de conciencia, que se interpretó en contexto de lesión talámica.

Tromboprofilaxis: tras confirmar estabilidad de hematoma, se inició y mantuvo tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular.

Dada evolución favorable y paciente clínicamente estable, se decidió el 13/04 traslado a UTAC para continuar con manejo.

Evolución en UTAC y sala neurología:

Neurológico: el paciente se mantuvo estable desde el punto de vista neurológico, con buen control de cifras tensionales con uso de antihipertensivos orales. No presentó eventos sugerentes de comicialidad, y se realizó un electroencefalograma que informó disfunción lenta continua generalizada. Se controló niveles plasmáticos de fenitoína, infraterapéuticos, por lo que se decidió suspender fenitoína.

Dado que evolucionó con delirium hipoactivo, se suspendió risperidona el 18/04.

Posteriormente, paciente con evolución neurológica favorable, con mantención de vigilia espontánea.

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 14:43

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 14:43:51

Página 3 de 5

Examen neurológico de egreso: vigil, desorientado en tiempo y espacio, disartria moderada, hipofonía, sin afasia, inatento. Bradipsíquico. Pupilas isocóricas reactivas, OCM normal, PFC izquierda, corneales presentes, lengua en línea media; paresia braquio-crural izquierda: braquial M4 y crural M3+; hemihipoestesia izquierda; cerebeloso normal a derecha.

Por historia previo a hospitalización de ataxia e incontinencia urinaria, se decidió complementar estudio con una RM de encéfalo con gadolinio, con plan de realizarla de forma ambulatoria.

Rehabilitación :

- Kinesioterapia: paciente con evolución kinesiológica favorable, actualmente con control regular de tronco y logrando bípedo con asistencia leve-moderada, con plan de mejorar control de tronco, reeducación de transiente sedende-bípedo, mejorar la estabilidad en bípedo e iniciar marcha.
- Fonoaudiología: actualmente con disfagia leve FILS8 e indicación de régimen licuado + líquidos claros, hiposódico.
- Terapeuta ocupacional: se mantiene en controles para estimulación.

Hemodinámico: paciente se mantuvo con tendencia a la hipotensión con fármacos antihipertensivos orales, ajustándose el esquema a: losartán 50 mg/día, amlodipino 10 mg/día, hidralazina 50 mg cada 8 hrs, espironolona 25 mg/día, carvedilol 12,5 cada 12 hrs. Dado hipertensión de difícil manejo y de inicio precoz con hipokalemias persistentes, se sospechó desde ingreso un hiperaldosteronismo primario. Se gestionó solicitud de estudio con Renina plasmática que no fue posible de realizar dado deterioro de conciencia y traslado a UPC. Dado que actualmente se encuentra con esquema que altera el eje renina-angiotensina-aldosterona, se definió ese estudio para realizarlo a futuro una vez mejor controlado PA y ajuste de esquema antihipertensivo. Endocrinología al tanto de esta situación y sugieren de todas maneras reevaluación ambulatoria. Se solicitó Eco TT como estudio de daño de órgano blanco, objetado por cardiología.

Infeccioso: durante su estadía inicial en UTAC y UPC, el paciente presentó neumonía aspirativa con CAET (+) a Serratia marcescens, tratado por 7 días con ampicilina-sulbactam y luego Tazonam. Posteriormente presentó bacteremia por Serratia marcescens, por lo que se inició tratamiento con meropenem, completando 14 días. Hemocultivos de control del 14/04 negativos y PCR 1,4 (25/04). Hemocultivos de control del 21/04 con resultado aún pendientes (a la fecha, 26/04).

Infectología sugirió realizar ecocardiogramaTE para estudio de endocarditis si persiste con bacteremia por Serratia marcescens o si presenta deterioro clínico.

Posteriormente, sin intercurrentia infecciosa actual.

Hidroelectrolítico: durante estadía en UTAC cursó con elevación de BUN hasta 51, asociado a signos de VEC bajo. Se indicó agua libre con posterior descenso del BUN. Control 25/04: creatinina 0,67 y BUN 31,2

Urológico:

- Dado estudio de incontinencia previa, se solicitará realizar ecografía prostática y APE de forma ambulatoria, con control en urología.

Diagnósticos Actuales:

1. Hematoma talámico derecho ICH 1 (por vaciamiento ventricular).
Disfagia leve en rehabilitación
Hemiparesia izquierda y alteración de la marcha en rehabilitación
2. Bacteriemia y neumonía por Serratia marcescens, tratada con meropenem por 14 días.
3. Hipokalemia leve, resuelta.
4. AKI prerrenal, resuelta
5. COVID-19 (PCR + 25/03)
6. Antecedentes: HTA refractaria Obs 2° en estudio, DM2NIR.

Dada evolución estable, se decidió continuar con rehabilitación en el Hospital San José de Maipo.

Escobar/Eugenín

Diagnóstico de Egreso

Hematoma intracerebral - Talámico derecho, ICH 1, de etiología hipertensiva
DISFAGIA - Leve FILS 8, en rehabilitación. Régimen licuado + líquidos claros
ANORMALIDADES DE LA MARCHA Y DE LA MOVILIDAD - En rehabilitación

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 14:43

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 26-04-2022 14:43:51

Página 4 de 5

OTRAS SEPTICEMIAS - Bacteremia por *Serratia marcescens*
NEUMONIA DEBIDA A OTROS MICROORGANISMOS INFECCIOSOS ESPECIFICADOS - Neumonía por *Serratia marcescens*, tratada
HIPOPOTASEMIA - Leve, resuelta
INSUFICIENCIA RENAL AGUDA - Resuelta
HIPERTENSION SECUNDARIA - En estudio
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE -

Condición de Egreso Alta Derivado al Hospital San José de Maipo

Egreso con Catéter Doble J: NO

Examen Neurológico traslado

-Vigil, desorientado TE, disartria moderada, hipofonía, sin afasia, inatento. Bradipsíquico.
-Isocoria, RFM +/+, OCM normal, PFC izquierda, corneales presentes, lengua en LM
-Paresia BC izquierda B M4 C M3+
-Hemihipoestesia izquierda
-Cerebeloso N a derecha

NIHSS: 0-0-0-0-0/1-0-0-1-0/0-1-0-1-1 5 puntos

Plan Post Alta

Regimen: licuado más líquidos
Reposo: levantar por kinesiólogo
Rehabilitación: kinesiólogo, fonoaudiología

Medicamentos

- Amlodipino 10 mg al día VO
- Bromuro ipatropio inhalador 2 puff cada 8 horas
- Carvedilol 25 mg, 1/2 comprimido cada 12 horas VO
- Enoxaparina 40 mg SC al día
- Espironolactona 25 mg al día VO
- Hidralazina 50 mg cada 8 horas VO
- Losartan 50 mg al día VO
- Omeprazol 20 mg al día VO
- Paracetamol 1 gramo cada 8 horas VO
- PEG 25 gramos cada 12 horas VO para asegurar 1 deposición al día

Controles

- Control con NEUROLOGIA en CDT HSR. Solicitar hora al alta con epicrisis
- Control con NEFROLOGIA en CDT HSR al alta para estudio de HTA secundaria.
- Control con ENDOCRINOLOGÍA en CDT HSR al alta para estudio de hiperaldosteronismo primario.
- Control con UROLOGÍA en CDT HSR al alta para estudio de incontinencia urinaria.

Escobar/Eugenín

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar Por Kinesiólogo

Régimen Alimentario : Licuado + Líquidos Claros

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 26/04/2022 14:43

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 14:55

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

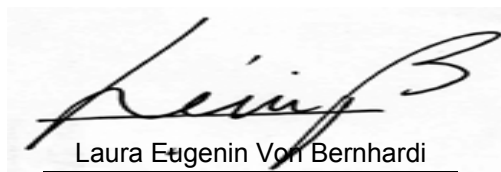
Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: BORRADOR



Fecha Última Actualización: 26-04-2022 14:43:51

Página 5 de 5



Laura Eugenin Von Bernhardt

Becado/Residente



Philippe Grandjean Silva

Médico Tratante (Staff)

INTERNO